

Hoolduskoormuse vähendamise esmased abinõud

Häli Tarum

hoolekande osakonna juhataja, sotsiaalministeerium

Selle aasta lõpus jõuavad Vabariigi Valitsusse hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma töö tulemusena valminud poliitikasoovitused. Nendele tuginedes peab valitsus otsustama, kuidas probleemi lahendamiseks edasi liikuda. Kuid paljuski tänu rakkerühma olemasolule ja teema aktuaalsusele tuli valitsuse tegevusprogrammi kohaselt sotsiaalministeeriumil juba 2017. aastal esitada valitsusele rahastusettepanekud, kuidas toetada hoolduskoormuse vähendamist aastatel 2018–2021. Sotsiaalministeeriumi kokku pandud ettepanekud kiitis valitsus heaks käimasoleva aasta septembris ja nii olemegi teinud kibekiiret tööd, et tegevusi saaks hakata ellu viima.

Neli uut tegevussuunda

Esmaste rahastusettepanekute kokkupanemisel lähtuti ühelt poolt rakkerühmas tõstatatud probleemidest ning teiselt poolt oli oluline suunata lisaressursse nendesse kohtadesse, kus probleem on kõige pakilisem. Seega oli esmajärjekorras asjakohane alustada kvaliteetsete teenuste pakkumisega suurema hooldusvajadusega inimestele. Samuti oli vaja luua alused sotsiaal- ja tervishoiuteenuste koordineeritud osutamiseks ning toetada hooldajate töö-, pere- ja isikliku elu ühita-

mist. Nii leidsidki valitsuses kinnitamist neli tegevussuunda:

- 1) uus teenus uuele sihtrühmale: päeva- ja nädalahoiu teenus intellektihäirega täisealistele
- 2) kohandatud teenusekohad dementsuse diagnoosiga eakatele ja dementsuse alase kompetentsi tõstmine
- 3) sotsiaal- ja tervisesektori vahelise hooldest puudutava koordineerimisüsteemi katsetamine
- 4) lisapuhkepäevad sügava puudega inimese töötavale pereliikmele.

Päeva- ja nädalahoiu teenus

Koos huvirühmade ja Sotsiaalkindlustusametiga töötasime selle aasta sügisel välja uue teenuse suures mahus hooldest, järelevalvet ja kõrvalabi vajavatele raske või sügava intellektihäirega täiskasvanutele. Nimetatud sihtrühmal on alates 2018. aastast võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust ühes kuus kuni 21 ööpäeva.

Oluline on teenuse pakkumisel lähtuda hooldest vajava inimese ja tema perekonna vajadustest. Mõnel juhul soovivad pereliikmed kasutada teenust ainult tööpäevadel ja päevasel ajal, teise perekonna vajadused võivad olla aga hoopis vastupidised. Seega nõuab

erinevaid võimalusi ja lahendusi pakkuv teenuse osutamine omamoodi paindlikkust ka teenuseosutajatel.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda lähimasse Sotsiaalkindlustusameti esindusse, kus hinnatakse, kas just nimetatud teenus on intellektihäirega inimesele sobilik. Vajaduse ilmnedes saadetakse inimene tema kodule kõige lähemal asuva teenuseosutaja juurde. Teenusel tagatakse lisaks tavapärastele igapäevaelu toetavatele tegevustele ka juhendamine ja abistamine riietumisel ja söömisel ning hooldus- ja hügieenitoimingutes. Samuti nõustatakse teenust saavate inimeste lähedasi, et nad mõistaksid ja tuleksid toime inimese erivajaduse ja võimalike käitumise eripäradega. Teenuse kasutajal tuleb tasuda omaosalus toitlustuse ja ööbimise korral ka majutuse eest. Omaosaluse tasumiseks on võimalik vajadusel taotleda abi kohalikul omavalitsuselt.

Dementsuse diagnoosiga eakad

Eakate hoolekandes on üheks kiireloomuliseks probleemiks dementsusega inimestele sobilike teenuste puudumine: spetsiaalselt dementsuse diagnoosiga eakatele mõeldud päevahoiuteenust pakutakse vähe ja üldhooldekodude ruumid pole alati dementsusega inimeste vajadustele sobilikud. Samuti on nii sotsiaaltöötajatel kui ka teistel spetsialistidel, teenuseosutajatel ja perekondadel puudus praktilisest teadmisest, kuidas dementsusega eakatega hakkama saada.

Selle probleemi leevendamiseks rajatakse sotsiaalministeeriumi eestvedamisel 2018. aastal dementsuse kompetentsikeskus, mille ülesanne on korraldada valdkonna võrgustikutööd, koondada tõenduspõhiseid metoodikaid, häid praktikaid ja ekspertiisi, töötada välja koolitusmaterjale, viia läbi koolitusi ning arendada tugiteenuseid. Samuti hakkab kompetentsikeskus nõustama teenuseosuta-

jaid sobivate töövõtete kasutusele võtmisel, füüsilise keskkonna kohandamisel, teenuste arendamisel ja käivitamisel ning keerulismate juhtumite lahendamisel.

Lisaks saavad üldhooldekodud taotleda sotsiaalministeeriumist toetust, et kohendada ruumid dementsuse diagnoosiga eakatele sobivaks. Toetust on võimalik küsida nii ruumide renoveerimiseks kui ka väiksemate juurdeehitiste tegemiseks. Näiteks saavad hooldekodud toetuse abil soetada häirenuppe, paigaldada aiapiirdeid, luua teraapiaruumi või paigaldada silte ja märke, mis aitavad dementsuse diagnoosiga eakatel hooldekodus ringi liikuda. Riigieelarves on selleks ette nähtud 1,2 miljonit eurot ning niipea kui toetuse saamise tingimused on koostöös kompetentsikeskusega välja töötatud, anname toetuste taotlemise kohta ka rohkem informatsiooni.

Hoolduse koordineerimise pilootprojekt ja lisapuhkepäevad

Praegu puudub hoolduse korraldamisel, teenuste vajaduste hindamisel ja pakkumisel inimese terviklikest vajadustest lähtuv lähenemine, st inimese vajadusi ei hinnata komplekselt ja keskne (sektorite ja tasan-dite vaheline) koordineerimine on puudulik. Tihtipeale on ka hooldusvajadusega inimese pere liikmed ise justkui valdkondade vahelised juhtumikorraldajad, kellele tuleb erinevate teenuste saamiseks pöörduda erinevate asutuste poole.

Probleemi lahendamiseks töötame välja mudeli, mis integreerib sotsiaal- ja tervisevaldkonnas pakutavad teenused ning katsetame seda aastatel 2018–2019 mõnedes kohalikes omavalitsustes. Mudeli paika seadmisel lähtume rakkerühma ettepanekutest ning kindlasti on ka huvirühmadel võimalik mudeli väljatöötamisse enne selle katsetamist panustada.